

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 04

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

La santé : état de complet de bien-être physique, mental et social, n'est pas un bien ou un produit marchand (OMS)

Economie : Science qui étudie la façon dont les personnes et la société produisent et emploient les ressources.

Agent économique : Personne ou groupe de personnes qui participe réellement à l'activité économique.

Activité économique : Production des B&S pour satisfaire des besoins.

Sciences économiques : Lois qui régissent la production, la distribution et la consommation B&S

Le lien entre santé et économie : l'économie de la santé appelle un compromis :

- ❖ Celui de la santé dont la finalité est de toujours mieux soigner.
- ❖ Celui de l'économie qui est de toujours mieux dépenser.

L'économie est l'étude de la façon dont les personnes et la société emploient des ressources productives rares (pour lesquelles des utilisations alternatives sont possibles) pour produire différentes marchandises, les distribuer dans les différents groupes de la société et les consommer. (Le cycle de l'activité économique).

La branche de l'économie qui traite de la production de biens et de services médicaux, de leur répartition, c'est à dire de l'accès aux soins et de la formation des prix."

Microéconomie : analyse du comportement économique au niveau d'entités individuelles telles qu'un consommateur ou vendeur ou encore le prix sur le marché d'un produit déterminé

Macroéconomie : fonctionnement d'ensemble de l'économie, à travers l'étude des agrégats économiques (PIB, dépenses de santé) et les relations existantes entre eux. (Chômage, inflation...)

Agrégat économique : la somme ou la soustraction de plusieurs données économiques (valeur ajoutée d'une entreprise, le PIB...)

4 concepts fondamentaux en économie :

- ❖ **La rareté des ressources :** dimension sociale
- ❖ **Le choix / la décision :** allocation du disponible entre différents usages
- ❖ **Le coût d'opportunité :** meilleur usage des ressources sacrifiées
- ❖ **L'efficacité économique :** faire des choix pour que les bénéfices soient supérieurs aux coûts.

Performance chez un économiste

Deux critères pour mesurer la performance : **l'efficience et l'équité**.

- ❖ La notion de **l'efficience** couvre au moins 3 dimensions fortement imbriquées : l'efficacité médicale, l'efficience technique et l'efficience économique
- ❖ La notion de **l'équité** : l'accent est mis sur le financement du système de santé (équité verticale) et sur les soins et l'état de santé (équité horizontale).

1. La notion de l'efficience

- ❖ **L'efficacité médicale** : met en relation santé et soins de santé, sans dimension de coût. Il s'agit ici de connaître la contribution des soins de santé à l'amélioration de la santé.
- ❖ **L'efficience technique** : met en relation les inputs avec les outputs (facteur travail et facteur capital avec la contribution à la production de soins de santé).
- ❖ **L'efficience économique** : met en relation l'amélioration de l'état de santé et les coûts.

2. La notion de l'équité

- ❖ **Équité verticale** : Les personnes qui ont des capacités contributives inégales assurent une participation inégale au financement du système de santé. Autrement dit, ceux qui ont les revenus les plus élevés, contribuent en fonction de leurs moyens.
- ❖ **Équité horizontale** : L'accent est mis sur l'égalité de traitement pour ceux qui ont des besoins de santé égaux. (Le principe d'une égalité de ressources attribuées à des régions qui ont le même état de santé).

Principes de base en économie de santé :

- ❖ La plupart des règles qui régissent l'économie de marché ne sont applicables telles quelles aux soins de santé (santé = bien particulier car le patient est incapable de décider seul de son traitement et il ne paie pas souvent le prix réel des prestations fournies) ;
- ❖ La demande de soins est infinie et les ressources limitées (les limites des budgets santé par pays) ;
- ❖ Avant d'allouer une ressource, toutes les alternatives doivent être évaluées

Objectifs d'économie de la santé :

- ❖ Rechercher la meilleure utilisation des ressources.
- ❖ Evaluation en termes de **coûts** et **d'efficience** de la production de soins et de services médicaux alloués à une population et surtout la proposition des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.
- ❖ Atteindre les objectifs du développement humain dans un cadre de ressources limitées.

Le produit intérieur brut (PIB) :

- ❖ Correspond à la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidents à l'intérieur du territoire national.
- ❖ C'est aussi la mesure du revenu provenant de la production dans un pays donné. On parle parfois de production économique annuelle ou simplement de production.
- ❖ Une économie produit des milliers de biens et services différents.
- ❖ La production n'est pas une bonne mesure de la quantité produite dans un pays durant une année car beaucoup de biens servent à fabriquer d'autres biens et le prix de chaque bien incorpore le prix des consommations intermédiaires. «Double comptage» On utilise le concept de valeur ajoutée
- ❖ La VA est l'augmentation de la valeur des biens qui résulte du processus de production.

$$VA = \text{production} - \text{consommations intermédiaires}$$

$$PIB = \text{somme des valeurs ajoutées} + \text{impôts sur les produits} - \text{subventions à l'importation}$$

Le produit national brut (PNB) :

- ❖ Le PIB mesure la richesse produite sur le territoire national. Or des entreprises étrangères produisent dans un pays mais rapatrient une partie des revenus dans leur pays d'origine.
- ❖ Ces revenus ne bénéficient pas aux agents nationaux.
- ❖ On utilise le concept du produit national brut

$$PNB = PIB + \{\text{revenue des facteurs en provenance du reste du monde}\} - \{\text{revenue des facteurs versés au reste du monde}\}$$

L'Indicateur de Développement Humain

L'IDH prend en compte trois séries de facteurs :

❖ Le niveau de santé

- L'espérance de vie à la naissance

❖ Le niveau d'éducation

- Taux d'alphabétisation des adultes
- Nombre moyen d'années d'études

❖ Le revenu moyen

- PIB par tête corrigé par la non prise en compte de revenus les plus élevés

Prix :

Résultante de la confrontation de deux forces contraires offre/ demande.

Coût :

C'est l'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service, ainsi que l'usure ou l'obsolescence (amortissement) des immobilisations nécessaires à cette production.

Tarif :

Prix fixé institutionnellement par une autorité pour des raisons économiques ou sociales

Coût direct :

Valeur des B&S pouvant être directement imputés à la production d'une prestation.

Coût indirect :

Valeur des conséquences liées à un phénomène, une action ou un programme (pertes de production de l'individu malade incapable de travailler).

Coût intangible :

Psychologique concernant les pertes d'activités domestiques et/ou d'activités de loisir et la souffrance physique et morale

Coût fixe :

Coût qui ne varie pas avec la quantité produite à court terme.

Coût variable :

Coût qui varie en fonction de la quantité produite.

Coût moyen :

C'est le nom donné au coût par unité de résultat produit, le coût moyen est le coût total de l'intervention divisé par le nombre total d'unités de résultat produites.

Coût marginal :

C'est le nom donné au coût supplémentaire de la production d'une unité supplémentaire de résultat par le même programme.

La consommation

Caractérise l'acte d'un agent économique (le consommateur) qui utilise (consommation finale) ou transforme (consommation intermédiaire) des biens et services. Cette utilisation ou transformation provoque la destruction immédiate (biens non durables) ou progressive (biens durables) des éléments consommés. D'un point de vue économique, la consommation (destructrice de valeur) s'oppose à la production (créatrice de valeur).

Consommation finale : C'est la consommation de biens et de services par les ménages pour leur propre usage. Elle comprend les dépenses sur les produits alimentaires, les vêtements, le logement, les transports, les loisirs, etc.

Consommation intermédiaire : C'est la consommation de biens et de services par les entreprises pour produire d'autres biens et services. Elle comprend les dépenses sur les matières premières, la main-d'œuvre, les services professionnels, etc.

Les biens durables

Sont des biens qui peuvent être utilisés pendant une longue période de temps, généralement plus d'un an. Ils comprennent des éléments tels que les voitures, les maisons, les appareils électroménagers et les meubles.

Les biens non durables

Sont des biens qui sont utilisés une seule fois ou pendant une courte période de temps, généralement moins d'un an. Ils comprennent des éléments tels que les aliments, les vêtements, les produits de nettoyage et les produits de loisirs.

Facteurs influençant la consommation des soins

Facteurs socio-économiques

Revenu : Les personnes à revenu élevé consomment généralement plus de soins que celles à revenu faible.

Niveau d'éducation : Les personnes plus instruites ont tendance à être plus conscientes de l'importance de la santé et à avoir une meilleure connaissance des services de santé disponibles.

Assurance maladie : La possession d'une assurance maladie encourage les gens à consulter un médecin et à se faire soigner.

Facteurs démographiques :

Âge : La consommation de soins augmente généralement avec l'âge.

Sexe : Les femmes consomment généralement plus de soins que les hommes.

Taille de la famille : Les familles nombreuses ont tendance à consommer plus de soins que les familles monoparentales ou les couples sans enfants

Facteurs géographiques et environnementaux :

Accessibilité aux services de santé : La distance aux services de santé et la qualité des transports peuvent influencer la consommation de soins.

Densité de la population : une densité de population élevée peut entraîner une augmentation de la consommation de soins de santé (Propagation des maladies, accès facile aux services de santé ...etc.

Pollution : La pollution peut avoir un impact négatif sur la santé et augmenter la demande de soins, **Les conditions de vie et de travail :** Les conditions de vie et de travail peuvent influencer la santé et la demande de soins.

Facteurs psychologiques :

Anxiété et dépression : Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression ont tendance à consommer plus de soins.

Facteurs technologiques :

Progrès technologiques : Les progrès technologiques permettent de développer de nouveaux traitements et de nouvelles techniques médicales, ce qui peut influencer la quantité et la qualité des soins disponibles.

Facteurs organisationnels :

Organisation du système de santé : La manière dont le système de santé est organisé peut influencer la production des soins.

Ressources humaines : Le nombre et la qualité des professionnels de la santé disponibles influencent la production des soins.

Facteurs économiques et politiques :

Ressources financières : Le montant des ressources financières disponibles pour le système de santé influence la quantité et la qualité des soins disponibles.

Politique de santé : les politiques gouvernementales en matière de santé jouent un rôle crucial dans la production des soins.

Evaluation économique

- ❖ Étude comparative des coûts et /ou des effets des interventions ou stratégies mises en œuvre en vue d'opérer un choix.
- ❖ Les tâches principales d'une évaluation économique sont d'identifier comparer, mesurer et les coûts et conséquences des alternatives étudiées.

Types d'évaluation économique

- ❖ **L'évaluation économique partielle** peut étudier les coûts ou les conséquences de programmes de santé, ou encore les coûts et conséquences d'un programme particulier.
- ❖ **L'évaluation économique complète** observe les coûts et les conséquences de plusieurs programmes et les compare.
 - Analyse coût-minimisation
 - Analyse coût- efficacité
 - Analyse coût- utilité
 - Analyse coût- bénéfice